

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN	Código: PRD-CL-03 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	---	---

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN

1. OBJETIVO

Estandarizar el registro, control y evolución de las sesiones de intervención terapéutica, asegurando la continuidad del tratamiento, la trazabilidad clínica secuencial y la protección inquebrantable de los datos sensibles del paciente.

2. ALCANCE

Inicia una vez establecido el plan de tratamiento en la fase de valoración y finaliza en el momento en que se cumplen los criterios clínicos para proceder con el cierre del proceso psicológico.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología Tratante.

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1090 de 2006 (Secreto Profesional e Intervención).
- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data y Datos Sensibles).

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Desarrollo de las Sesiones de Intervención: Aplicación de técnicas, modelos y estrategias de intervención psicológica basadas en evidencia científica, coherentes con el plan de tratamiento trazado inicialmente.
- 5.2. Registro Concurrente de Evolución: Documentar cada sesión en la Historia Clínica mediante 'Notas de Evolución'. El registro debe realizarse preferiblemente de forma inmediata o el mismo día de la atención. Debe contener: estado emocional actual del paciente, resumen de intervenciones realizadas, avances frente a los objetivos y tareas o recomendaciones dejadas.
- 5.3. Monitoreo Continuo de Riesgos Clínicos: Re-evaluar en cada encuentro factores de vulnerabilidad o crisis. Si se detecta un aumento en el nivel de riesgo (ej. aparición de

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN	Código: PRD-CL-03 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	---	---

ideación suicida o ideación de daño a terceros), documentarlo de inmediato y tomar acciones de contingencia y remisión a red de urgencias.

- 5.4. Custodia y Confidencialidad de la Información: Garantizar que la pantalla del software de historia clínica no esté visible para terceros durante la sesión. Asegurar que los expedientes digitales cuenten con claves robustas y las pruebas físicas estén resguardadas bajo llave.
- 5.5. Re-evaluación Periódica del Plan: Si el paciente no presenta mejoría en los tiempos estimados, el profesional debe reevaluar las hipótesis, replantear los objetivos terapéuticos o considerar éticamente la remisión a psiquiatría u otra especialidad afín.

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- Notas de evolución secuenciales, lógicas, fechadas y debidamente firmadas por el psicólogo tratante.
- Coherencia clínica entre el plan de intervención propuesto y las acciones reportadas en la evolución.
- Cero evidencias de vulneración de la custodia de la historia clínica durante inspecciones físicas.

Aprobó

Natalia Angel Usuga